# DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

**IDENTIFICACIÓN**

**Paciente:** RAFAEL ANTONIO RAMIREZ **Identificación** CC 94190495
**Edad:** 64 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
**Sala:** SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

**Sede de Atención:** SEDE PRINCIPAL

**CIRUGÍAS**

| CANT | CÓDIGO | NOMBRE DE LA CIRUGÍA | Grupo Quirúrgico | UVR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **452305** | **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA** | ANK | |

**Cirujano:** JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
**Vía:**

**DESCRIPCIÓN CIRUGÍA**

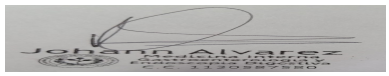
**CIRUJANO** ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
**452305** **COLONOSCOPIA TOTAL CON O SIN BIOPSIA**
**Dx Preoperatorio:** K573 ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL INTESTINO GRUESO SIN PERFORACION NI ABSCESO
**Dx Postoperatorio:** I842 HEMORROIDES INTERNAS SIN COMPLICACION

**Tipo de Herida:** LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
**Cantidad de Sangrado:** 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
**Clasificación de riesgo quirúrgico :** **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
**Realización Acto Quirúrgico:** **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
**Hora Inicio** 14:20:00 **Hora Final** 14:32:00
**Tiempo de Perfusión:** 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

**Descripcion Quirúrgica:**
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****COLONOSCOPIA****
***INDICACIÓN: Sindrome constitucional
INSPECCIÓN: Normal
TACTO RECTAL: Normal
COLONOSCOPIA: Explorado hasta región cecal (identificando orificio apendicular y válvula ileocecal) observando abundante materia fecal sólida en ciego y colon ascendente que no evacúa a pesar de lavado exhaustivo, sin embargo, en lo valorado, observando múltiples orificios diverticulares sin sangrado, sin edema. No se evidencian signos que sugieran neo, sangrado activo ni reciente en este estudio. Canal anal paquete hemorroidal. Procedimiento sin complicaciones aparentes. Preparación Boston CD: 1, CT: 2, CI: 3 6/9.
***CONCLUSIÓN:
1. DIVERTICULOSIS PANCOLONICA
2. HEMORROIDES GRADO I/IV

**Complicaciones :** **SI** ☐ **NO** ☒

**Tejidos enviados a patología :** **SI** ☐ **NO** ☒



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***